要約レポート: 傷病分析_ICD10-base.pdf

作成日時: 2025-11-20 13:42

傷病分析レポート：ICD10コードに基づく傾向分析

1. はじめに

本レポートは、提供された傷病データとICD10（国際疾病分類第10版）コードに基づき、傷病の分類、未入力割合、年齢・性別・時間帯別の傾向を分析したものです。視覚的なグラフと具体的な数値を用いて、データから読み取れる主要な知見を要約し、今後の医療データ活用や公衆衛生施策立案に資する情報を提供することを目的とします。

2. データ準備と分類方法

分析に際し、傷病名カラムと傷病名_ICD10コードを用いてデータをグループ分けしました。データの状態を確認したところ、傷病名カラムが入力されているレコードのICD10コードはすべて入力済みであったため、ICD10コードを元に分類分けを行いました。

ICD章分類マッピング

ICD10コードの先頭文字（アルファベット）を基に、以下のルールで傷病を分類しました。

- A, B: 感染症
- C: 腫瘍
- D: 血液・免疫
- E: 内分泌・代謝
- F: 精神・行動
- G: 神経
- H: 感覚器（眼・耳）
- I: 循環器
- J: 呼吸器
- K: 消化器
- L: 皮膚
- M: 筋骨格
- N: 泌尿・生殖器
- O: 妊娠・出産
- P: 周産期
- Q: 先天異常
- R: 症状・異常所見
- S: 損傷（外因）
- T: 中毒・外因
- V, W, X, Y: 事故・傷害外因、外因その他（救急データでは損傷に分類する慣習あり）

- Z: 健康管理
- U: 新型感染症

3. 全体的な傷病分類の傾向

所持データにおけるICD章分類の分布を見ると、特定のカテゴリに件数が集中していることが分かります（図1, 図3参照）。

- 最も件数が多いカテゴリ:
- 「症状・異常所見（R）」 が70,000件以上と圧倒的に多く、病名がはっきりせず救急到着時点でのめまいや発熱などが含まれると考えられます。
- 次に多いのは 「損傷（外因）（S）」 で、約55,000件を占めています。
- 「不明」カテゴリの件数:
- 分類が特定できなかった 「不明」 の件数も約32,000件と非常に多く、データ品質や分類プロセスにおける課題を示唆しています。
- 主要な臓器系疾患:
- 「循環器（I）」 が約29,000件、「呼吸器（J）」 が約17,000件、「消化器（K）」 が約14,000件と続きます。
- 件数が少ないカテゴリ:
- 「先天異常（Q）」（約100件）、「周産期（P）」（約200件）、「妊娠・出産（O）」（約300件）などは件数が非常に少ない傾向にあります。

4. 傷病名_ICD10コード未入力割合の推移

年ごとの傷病名_ICD10コード未入力割合は、以下の顕著な傾向を示しています（図2参照）。

- 初期の改善と緩やかな増加: 2002年の7.9%から2004年には6.0%まで一時的に改善しましたが、その後は緩やかに増加し、2010年代半ばには11%台で推移しました。
- 急激な悪化: 2018年以降、未入力割合は急激に上昇し、2022年には過去最高の21.3%に達しました。これは、2004年の最低値と比較して3倍以上の割合です。テキスト情報によると、この急上昇は「コロナ中期ごろ」と重なる時期です。
- 近年の改善傾向: 2022年のピーク以降は減少に転じ、2023年には18.2%、2024年には15.2%に低下しています。しかし、この数値は2020年以前のどの年と比較しても依然として高い水準であり、継続的な対策の必要性を示唆しています。

5. 年齢とカテゴリー分布

年齢区分とICD章分類の件数分布をヒートマップで確認すると、年齢層ごとの特徴が明確に現れています（図4参照）。

- 高齢者層（特に75歳以上）の件数の多さ:
- 「75歳以上」 の層は全体的に件数が多く、特に 「症状・異常所見」が30,802件、「呼吸器」が19,958件、「内分泌・代謝」が9,352件と、多くの分類で高い件数を示しています。
- 若年層の傾向:
- 「生後28日未満」 や 「生後28日以上1歳未満」 では 「周産期」 や 「先天異常」 が比較的多く見られます。

・「18歳以上40歳未満」 では 「損傷（外因）」が9,242件と非常に多く、この年齢層での事故や怪我の発生率が高いことを示唆しています。
・「不明」カテゴリ:
・年齢区分が 「不明」 の場合、ICD章分類も 「不明」 であるケースが
5,769件と最も多く、データ収集における課題を示唆しています。

6. 年ごとのカテゴリー件数推移（上位8カテゴリ）

件数の多い上位8カテゴリーについて、年ごとの推移を見ると、特定のカテゴリで強い上昇傾向が見られます（図5参照）。

・「症状・異常所見」: 2003年頃の約2,000件から一貫して増加し、特に2018年以降は急増して2024年には5,500件を超えています。
・「不明」: 2003年から2018年頃までは比較的低い水準でしたが、2019年頃から急激に増加し、2022年には3,500件を超えるピークに達した後、急激に減少しています。これは、特定の期間におけるデータ入力や分類方法に一時的な変更があった可能性を示唆しています。
・「損傷（外因）」:
2003年頃の約2,400件から緩やかに増加し、2024年には3,000件を超えています。
・その他のカテゴリ（循環器、呼吸器、消化器、中毒・外因、筋骨格）は、比較的安定しているか、緩やかな増加傾向を示しています。

7. 特定カテゴリーの年ごとの年齢別件数推移

7.1. 症状・異常所見

「症状・異常所見」カテゴリでは、75歳以上のグループが他の年齢区分に比べて飛びぬけて上昇しています（図6参照）。

・75歳以上:
2003年頃の年間約500件から、2024年には約2,800件近くまで劇的に増加しています。
・中高年層: 「40歳以上65歳未満」や「65歳以上75歳未満」も増加傾向にありますが、75歳以上の層ほどの急激な増加ではありません。
・若年層・成人層: 他の年齢層は比較的安定しているか、緩やかな増減を繰り返しています。
75歳以上の男女別:

75歳以上の「症状・異常所見」では、女性の件数が男性を上回って推移しており、2024年近くでは男性が1,300件台、女性が1,500件台に達しています
（図7参照）。両性ともに増加傾向にありますが、女性の件数が一貫して多い状況です。

7.2. 不明

「不明」カテゴリでは、特定の年齢層で急激な変動が見られます（図8参照）。

・40歳以上65歳未満: 2015年頃から急激に件数が増加し始め、2022年頃には1,000件を超えるピークに達した後、減少しています。
・75歳以上: 同様に2010年頃から着実に増加し、2022年頃には900件近くのピークに達した後、減少しています。

- 年齢不明: グラフ初期（2002年頃）には約750件と高かったものの、2005年頃にかけて急減し、その後は比較的安定しています。

7.3. 損傷（外因）

「損傷（外因）」カテゴリでは、高齢者層と若年成人層で対照的な推移が見られます（図9参照）。

- 75歳以上: 2003年頃の約350～400件から、一貫して急激な増加を続け、2024年頃には1,700件を超える水準に達し、全年齢層の中で圧倒的に最も高い件数となっています。
- 18歳以上40歳未満: 2003年頃には最も高い件数（約750件）を示していましたが、その後は一貫して大幅な減少傾向にあり、2024年頃には約250～300件まで減少しています。
- 件数の逆転: 2008年ごろに75歳以上の件数が18歳以上40歳未満の件数を逆転し、それ以降は75歳以上が急激に伸びています。これは、各年齢グループごとの人口分布が影響している可能性があり、人口あたりの件数割合も見る必要があります。

損傷の75歳以上男女別:

75歳以上の「損傷（外因）」では、女性の件数（2024年近く1,000件超）が男性（2024年近く約600件）を大幅に上回り、近年その差が開いてきています
(図10参照)。高齢者人口における女性の割合が高いことが影響している可能性があります。

損傷の18-40歳男女別:

18歳以上40歳未満の「損傷（外因）」では、男女ともに件数が半減しています（図11参照)。男性は2003年頃の530件超から2024年頃には160件程度に、女性は2003年頃の220件から2024年頃には80件台後半に減少しています。これも年齢グループごとの人口が影響している可能性があり、要確認です。

8. 時刻別の件数推移

全期間の時刻別件数推移では、朝と夕方に「症状・異常所見」と「損傷」が増加する傾向が見られます。

- 75歳以上に限定: 朝8時から9時に件数が増加し、夕方は比較的少なめです。
- 75歳未満に限定: 朝は「損傷」が急増し、「症状・異常所見」は75歳以上に比べ緩やかです。全体的には夕方以降に最も増加する傾向があります。
- 2024年に限定:
- 75歳以上: 全期間と近い傾向を示しています。
- 75歳未満: 夕方の増加傾向は全期間と同じですが、「不明」の割合が減少し、「損傷」が増加しています。

9. まとめと考察

本分析により、ICD10コードに基づく傷病データの多角的な傾向が明らかになりました。

- 高齢者層の健康問題の増加: 特に75歳以上の高齢者層において、「症状・異常所見」および「損傷（外因）」の件数が劇的に増加しており、日本の高齢化社会における医療ニーズの増大を強く示唆しています。女性の件数が男性を上回る傾向も顕著です。

- データ品質の課題: ICD10コードの未入力割合が2022年に21.3%と過去最高を記録し、その後減少傾向にあるものの依然として高い水準です。また、「不明」カテゴリの件数も多く、データ入力や分類プロセスの改善が喫緊の課題です。
- 特定の期間における変動: 「不明」カテゴリの件数が2019年頃から2022年頃にかけて急増し、その後急減するという特異な変動が見られました。これは、特定の社会情勢（例：COVID-19パンデミック）やデータ収集・分類基準の一時的な変更が影響している可能性があります。
- 若年成人層の損傷減少: 18歳以上40歳未満の「損傷（外因）」件数は大幅に減少しており、高齢者層とは対照的な傾向を示しています。これは、安全意識の向上や社会環境の変化が影響している可能性がありますが、人口構成の変化も考慮した詳細な分析が必要です。
- 時間帯別の傾向: 朝と夕方に特定の傷病が増加する傾向は、救急医療体制の最適化や予防策の検討に役立つ情報となります。

これらの分析結果は、医療資源の適切な配分、高齢者向けの予防策の強化、データ入力プロセスの改善、そして特定の期間における医療動向の深掘りといった、今後の施策立案において重要な示唆を与えるものです。

参考情報:

- Colab URL: https://colab.research.google.com/drive/1BRH9IRGtp3jvFmaz4gFjd_QU_z_VEEKv#scrollTo=7bLGyMEy8k51

添付資料・画像分析

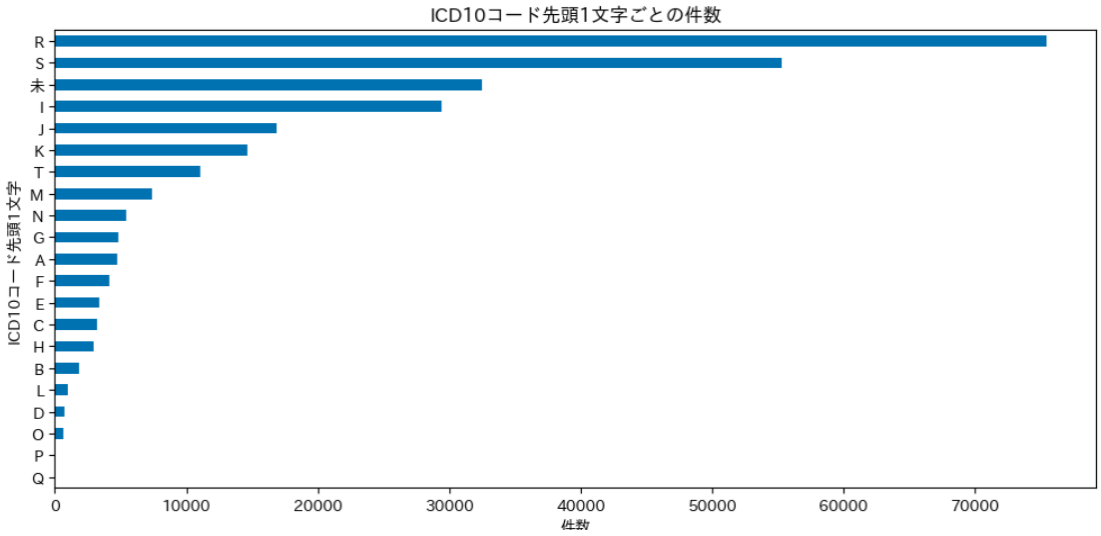

図1: 【図1】(Page 2): この画像（図1）は、ICD10コードの先頭1文字ごとの件数を棒グラフで表したものです。詳細な説明は以下の通りです。 1. グラフの種類: 横棒グラフ（Horizontal Bar Chart）です。各カテゴリの件数を視覚的に比較しやすいように、件数が多い順に並べられています。 2. タイトル: 「ICD10コード先頭1文字ごとの件数」 * ICD10コード: 「国際疾病分類第10版（International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision）」の略で、世界保健機関（WHO）が作成した疾病や関連する健康問題の分類コードです。医療機関での診断名や死因などを標準的に記録するために用いられます。 * 先頭1文字ごと: ICD10コードは通常、アルファベット1文字とそれに続く数字で構成されます（例: A00-B99, C00-D48など）。このグラフは、その最初のアルファベット（または特殊な分類）ごとに集計された件数を示しています。 * 件数: 各ICD10コードの先頭1文字に該当する事例や記録の総数を示します。 3. 軸の説明: * Y軸（縦軸）: 「ICD10コード先頭1文字」 * ICD10コードの最初の文字（例: R, S, J, I, Kなど）が並んでいます。 * 特筆すべきは「未」というカテゴリがあることです。これは「未分類」や「不明」といった、特定のICD10コードの先頭文字に分類できなかったデータを示していると考えられます。 * X軸（横軸）: 「件数」 * 各カテゴリに属する件数を示しており、0から70,000件を超える範囲で目盛りが振られています。 4. グラフから読み取れる主な情報: * 最も件数が多いカテゴリ: 「R」と「S」が最も多く、それぞれ70,000件を超えています。 * ICD10において、「R」は「症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの」を、「S」は「損傷、中毒及びその他の外因の影響」を指します。これらのカテゴリが非常に多いことは、症状や外傷に関するデータがこのデータセットで多くを占めていることを示唆しています。 * 「未」分類の件数: 「未」のカテゴリも非常に多く、約35,000件に達しています。これは、データの一部が標準的なICD10コードの先頭文字に分類されていないか、分類が不明な状態であることを示しており、データ品質や分類プロセスに関する考慮が必要かもしれません。 * 次に多いカテゴリ: 「J」（呼吸器系の疾患、約30,000件）、「I」（循環器系の疾患、約25,000件）が続きます。 * 件数が少ないカテゴリ: 「Q」（先天奇形、変形及び染色体異常）、「P」（周産期に発生した病態）、「O」（妊娠、分娩及び産褥）、「D」（血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害）、「L」（皮膚及び皮下組織の疾患）、「B」（特定の感染症及び寄生虫症）などは件数が非常に少ないことがわかります。 5. 全体的な解釈: このグラフは、ある特定のデータセット（例えば、病院の診療記録、保険請求データなど）において、どのような種類の疾病や健康問題が最も多く記録されているか、その大まかな傾向を示しています。特に、症状や外傷、呼吸器・循環器系の疾患が多い一方で、先天性疾患や周産期の病態などは少ないという分布が見て取れます。また、「未」分類のデータが無視できない量存在することも重要な点です。

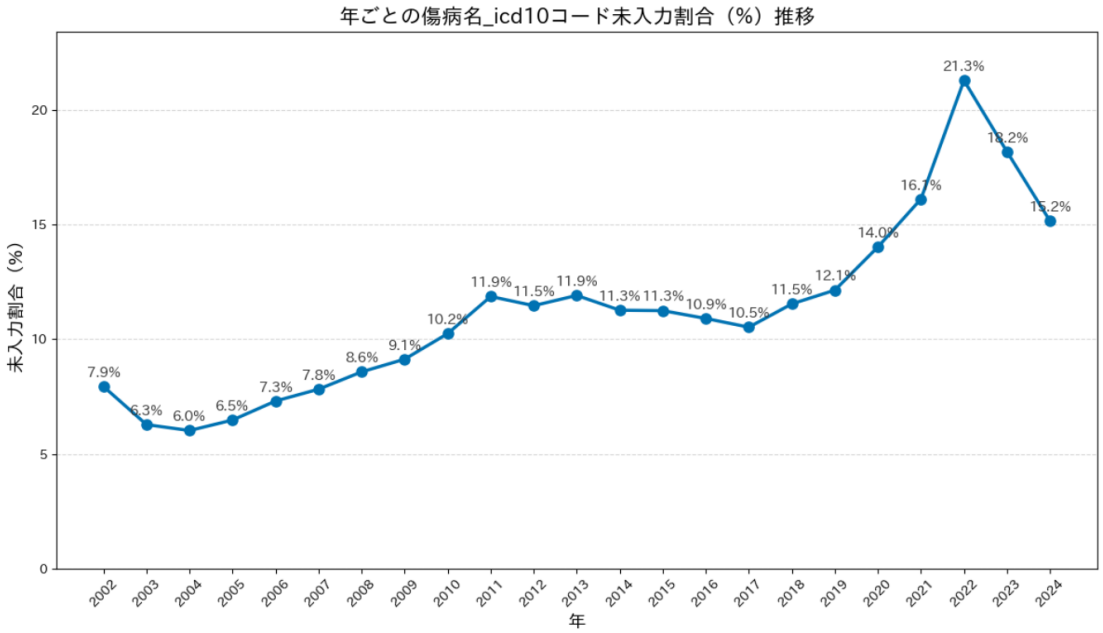

図2: 【図2】(Page 2):
この画像（図2）は、「年ごとの傷病名_ICD-10コード未入力割合（%）の推移」を示しています。
具体的には、以下の詳細を読み取ることができます。 1. グラフの目的: * 医療記録において、診断名（傷病名）に対応する国際疾病分類第10版（ICD-10）コードが入力されなかった割合が、年ごとにどのように変化してきたかを示しています。 *
これは、医療データの完全性や品質、あるいはコーディング基準への遵守状況を測る指標と考えることができます。 2. 軸の説明: * 横軸（X軸）: 「年」を表し、2002年から2024年までの期間をカバーしています。 * 縦軸（Y軸）: 「未入力割合（%）」を表し、ICD-10コードが未入力であった記録の割合を示しています。 3.
主要なトレンドと変化: * 初期（2002年～2004年）: * 2002年には7.9%の未入力割合で始まりました。 *
その後、2003年には6.3%、2004年には6.0%と、一時的に改善（未入力割合が減少）しました。 *
緩やかな増加期（2005年～2010年代半ば）: *
2005年以降、未入力割合は再び増加傾向に転じ、2005年の6.5%から2010年には10.2%に達しました。 *
2011年には11.9%に上昇し、その後数年間は11%台で推移しました（例:
2013年11.9%、2014年11.3%、2015年11.3%）。 *
2016年（10.9%）と2017年（10.5%）にはわずかに減少しましたが、初期の最低水準よりは高い状態でした。 *
急激な悪化期（2018年～2022年）: *
2018年（11.5%）から未入力割合が再び増加に転じ、その後は顕著な上昇を見せました。 * 2019年12.1%、2020年14.0%、2021年16.7%と連続して上昇し、2022年には過去最高の21.3%に達しました。これは、2004年の最低値（6.0%）と比較して3倍以上の割合です。 * 最近の改善傾向（2023年～2024年）: *
2022年のピーク以降、未入力割合は減少に転じています。 *
2023年には18.2%に、2024年には15.2%に低下しました。 * しかし、この15.2%という数値は、2020年以前のどの年と比較しても依然として高い水準であり、完全に問題が解消されたわけではないことを示唆しています。 4.
示唆されること: * このグラフは、医療データの品質管理、特にICD-10コードの入力徹底において、長年にわたる課題が存在することを示しています。 * 2018年から2022年にかけての急激な未入力割合の増加は、特定の期間にデータ入力体制やシステム、あるいは人員配置などに大きな変化や問題が生じた可能性を示唆しています（例えば、COVID-19パンデミックの影響なども考えられます）。 * ICD-10コードは、診療報酬請求、疫学調査、公衆衛生統計、医療研究など、多岐にわたる医療情報活用において不可欠であるため、その未入力割合が高いことは、これらの活動に影響を与える可能性があります。 * 最近の減少傾向は改善の兆しですが、依然として高い水準にあるため、継続的な対策が必要であることが読み取れます。

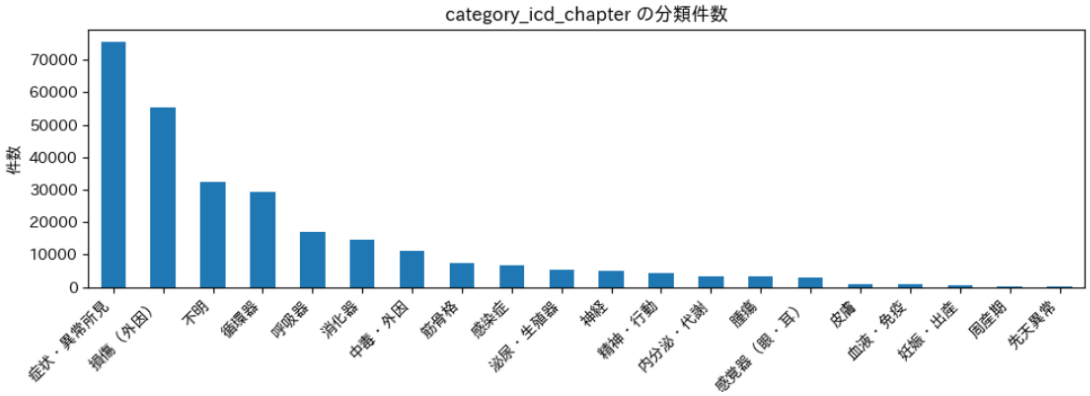

図3: 【図3】(Page 2): この画像（図3）は、「category_icd_chapter の分類件数」というタイトルが示す通り、国際疾病分類（ICD）の章（Chapter）に基づいて分類された医療関連データの件数（頻度）を棒グラフで表したものです。 詳細な説明は以下の通りです。 1. グラフの種類と目的: * これは棒グラフであり、各ICD章に属するデータの件数を比較するために使用されています。 * 目的は、分析対象となっているデータセットにおいて、どの種類の疾患や健康問題が最も多く記録されているか、その分布を視覚的に示すことです。 2. 軸の説明: * 横軸（X軸）: ICDの各章の名称が日本語で表示されています。これらは、特定の疾患群、症状、外因など、医療上の分類を示しています。グラフの左から右へ、件数が多い順に並べられています。 * 縦軸（Y軸）: 「件数」と表示されており、各ICD章に分類されたデータの数を表しています。0から70,000件以上の範囲で目盛りが振られています。 3. 主要な観察結果と解釈: * 最も多い分類: * 「症状・異常所見」 が圧倒的に多く、70,000件以上を占めています。これは、患者が医療機関を受診する際の初期段階で、まだ確定診断がついていない「症状」や「検査での異常所見」が最も多く記録されることを示唆しています。 * 次に多いのが 「損傷（外因）」 で、約55,000件です。これは、事故や外傷など、外部要因による損傷が医療機関で多く扱われていることを示しています。 * 上位の疾患分類: * 「不明」が約32,000件と3番目に多く、分類が特定できなかったり、情報が不足しているケースが少なくないことを示しています。 * 主要な臓器系に関する疾患では、「循環器」（約29,000件）、「呼吸器」（約17,000件）、「消化器」（約14,000件）が上位を占めています。これらは、一般的な生活習慣病や感染症など、罹患率の高い疾患群が含まれるため、件数が多くなる傾向があります。 * 中位の分類: * 「中毒・外因」（約10,000件）、筋骨格（約8,000件）、感染症（約6,000件）、泌尿・生殖器（約5,000件）、神経（約4,500件）、精神・行動（約4,000件）、内分泌・代謝（約3,500件）、腫瘍（約3,000件）、感覚器（眼・耳）（約2,500件）などが続きます。これらも医療機関で頻繁に扱われる疾患や状態ですが、上位の分類に比べると件数は少なくなります。 * 最も少ない分類: * 「先天異常」（約100件）、「周産期」（約200件）、「妊娠・出産」（約300件）、「血液・免疫」（約500件）、「皮膚」（約1,000件）などが最も少ない件数となっています。これらは特定の集団（妊婦、新生児）や比較的稀な疾患、あるいは専門外来で扱われることが多い疾患群であるため、全体のデータセットの中では件数が少なくなる傾向があります。 4. このグラフから読み取れることの意義: * このグラフは、特定の医療データセット（例えば、ある病院の診療記録、特定の地域のレセプトデータなど）における疾患や健康問題の「負荷」や「頻度」の傾向を把握するのに役立ちます。 * 医療資源の配分、公衆衛生上の優先順位付け、特定の疾患に対する介入策の計画などに活用できる情報を提供します。 * 「不明」の件数が多いことは、データ入力や分類プロセスの改善の必要性を示唆している可能性もあります。 要するに、この図は、ある医療関連データにおける疾患や症状の分類ごとの件数を可視化し、どの健康問題が最も多く発生しているか、あるいは記録されているかを示す頻度分布グラフです。

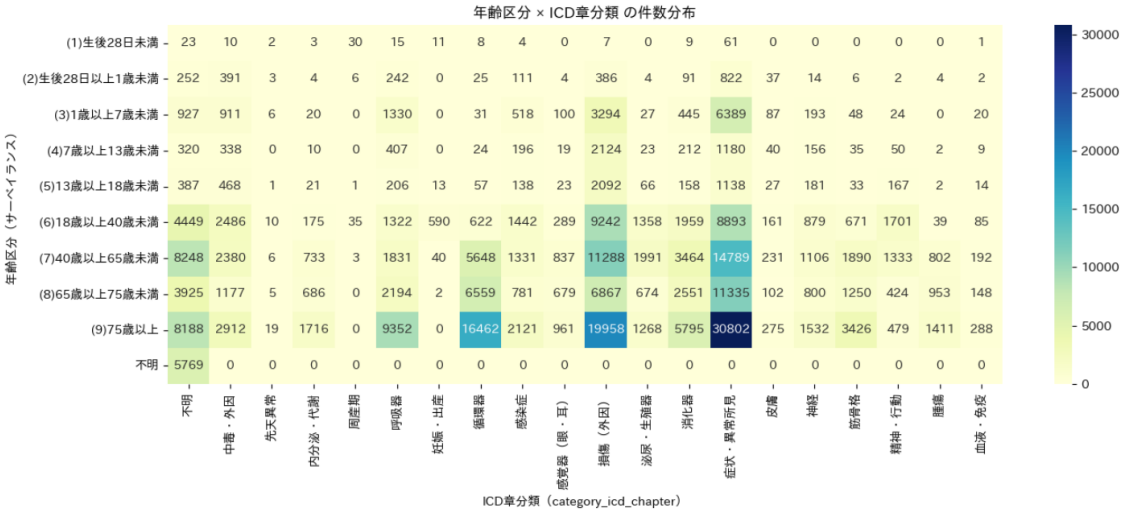

図4: 【図4】(Page 3): この画像（図4）は、「年齢区分 × ICD章分類 の件数分布」を示すヒートマップです。これは、特定の年齢層において、どのような疾患や健康問題（ICD章分類に基づく）が多く発生しているか、または記録されているかを示しています。 以下に詳細を説明します。 1. グラフの種類と目的: * これはヒートマップであり、各セルの数値（件数）の大小を色の濃淡で表現しています。色が濃い青色であるほど件数が多く、薄い黄色であるほど件数が少ないことを示します。 * 目的は、年齢層と国際疾病分類（ICD）の章分類という2つの軸に基づいて、それぞれの組み合わせにおける「件数」の分布を視覚的に把握することです。これにより、特定の年齢層でどのような健康問題が顕著であるかを一目で理解できます。 2. 軸の説明: * Y軸（縦軸）：年齢区分（サーベイランス）* 対象者を9つの具体的な年齢層と「不明」に分類しています。 * (1) 生後28日未満（新生児期）* (2) 生後28日以上1歳未満（乳児期）* (3) 1歳以上7歳未満（幼児期）* (4) 7歳以上13歳未満（学童期前半）* (5) 13歳以上18歳未満（学童期後半・思春期）* (6) 18歳以上40歳未満（若年成人期）* (7) 40歳以上65歳未満（中年期）* (8) 65歳以上75歳未満（前期高齢者）* (9) 75歳以上（後期高齢者）* 不明（年齢が特定できないケース）* X軸（横軸）：ICD章分類（category_icd_chapter）* 国際疾病分類（International Classification of Diseases, ICD）の主要な章に基づいて、疾患や健康問題を分類しています。 * 不明（分類が特定できないケース）* 中毒・外因（中毒や外部からの要因による影響）* 先天異常（生まれつきの異常）* 内分泌・代謝（内分泌腺の疾患や代謝異常）* 周産期（出産前後の期間に特有の病態）* 呼吸器（呼吸器系の疾患）* 妊娠・出産（妊娠、分娩、産褥に関連する病態）* 循環器（心臓や血管の疾患）* 感染症（細菌、ウイルスなどによる感染症）* 感覚器（眼や耳の疾患）* 損傷（外因）（外部からの要因による身体の損傷）* 泌尿・生殖器（泌尿器系や生殖器系の疾患）* 消化器（消化器系の疾患）* 症状・異常所見（診断が確定していない症状や検査での異常所見）* 皮膚（皮膚の疾患）* 神経（神経系の疾患）* 筋骨格（筋肉や骨格の疾患）* 精神・行動（精神疾患や行動障害）* 腫瘍（良性・悪性腫瘍）* 血液・免疫（血液や免疫系の疾患）3. 色の凡例（カラーバー）：* 右側のカラーバーは、件数の範囲を示しています。 * 薄い黄色は0件に近いことを示し、濃い青色は30,000件に近いことを示します。 * これにより、各セルの色の濃さからおおよその件数を読み取ることができます。 4. 主な傾向と読み取れる情報: * 高齢者層（特に75歳以上）の件数の多さ: * 「(9) 75歳以上」の行は全体的に件数が多く、特に「症状・異常所見」が30,802件と最も多く、次いで「呼吸器」が19,958件、「内分泌・代謝」が9,352件、「循環器」が5,795件など、多くの分類で高い件数を示しています。これは、高齢になるほど複数の健康問題を抱えやすく、また診断が確定する前の症状や異常所見で受診するケースが多いことを示唆しています。 * 若年層の傾向: * 「(1) 生後28日未満」や「(2) 生後28日以上1歳未満」では、「周産期」や「先天異常」といった分類が比較的多く見られます。 * 「(6) 18歳以上40歳未満」では、「損傷（外因）」が9,242件と非常に多く、この年齢層での事故や怪我の発生率が高いことを示しています。また、「精神・行動」も1,701件と他の若年層に比べて目立ちます。 * 特定の疾患分類の傾向: * 「呼吸器」や「感染症」は、乳幼児期から高齢者まで幅広い年齢層で一定の件数が見られ、特に乳幼児期と高齢者で件数が多い傾向があります。 * 「妊娠・出産」は、予想通り「(6) 18歳以上40歳未満」の年齢層に集中しています。 * 「腫瘍」は、年齢が上がるにつれて件数が増加する傾向が見られます。 * 「不明」カテゴリ: * 年齢区分が「不明」の場合、ICD章分類も「不明」であるケースが5,769件と最も多く、データ収集における課題を示唆しています。 このヒートマップは、日本の医療データ（または特定のサーベイランスデータ）において、どの年齢層がどのような健康問題に直面しているか、あるいは医療機関を受診しているかという実態を把握するための重要な情報源となります。公衆衛生政策の立案や医療資源の配分を検討する上で役立つデータと言えるでしょう。

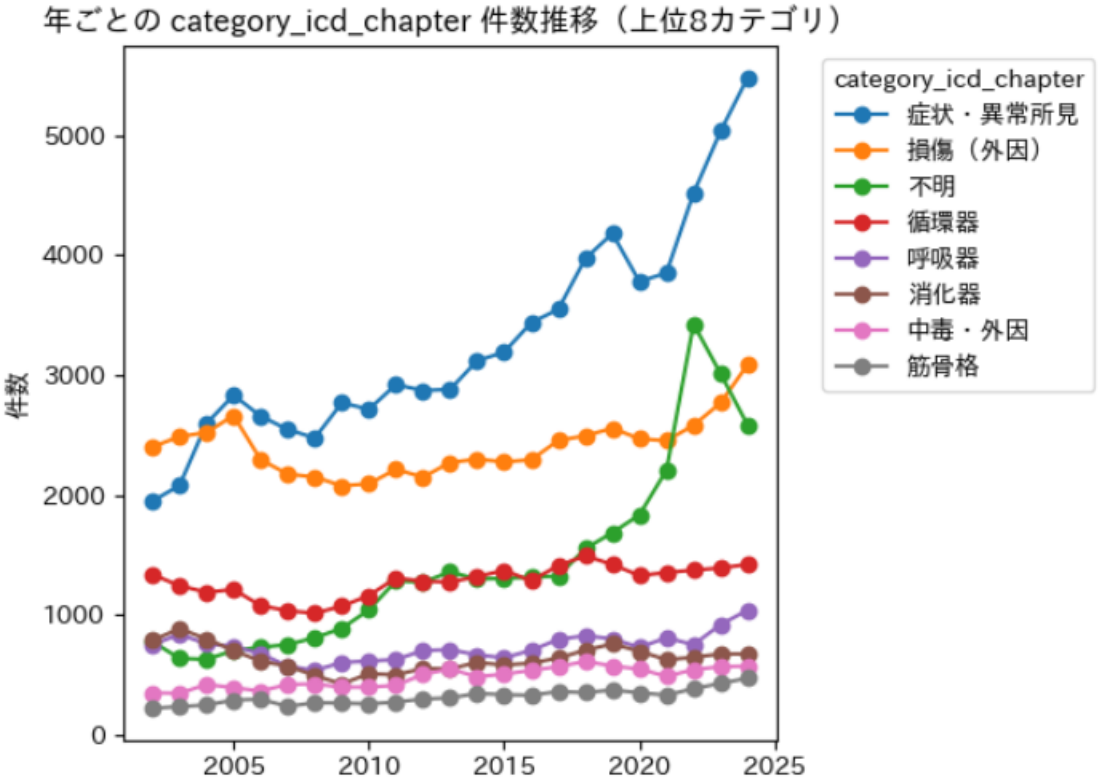

図5: 【図5】(Page 3): この画像（図5）は、「年ごとの category_icd_chapter 件数推移（上位8カテゴリ）」というタイトルが示す通り、国際疾病分類（ICD）の章（chapter）に基づいた上位8つのカテゴリについて、年ごとの件数の推移を示した折れ線グラフです。 具体的には、以下の要素と情報が読み取れます。 1. グラフの構成要素: * 横軸（X軸）: 年（おおよそ2003年から2024年まで） * 縦軸（Y軸）: 件数（0から5500件まで） * 凡例（category_icd_chapter）: 各折れ線がどのICDカテゴリを表しているかを示しています。 * 症状・異常所見（青線） * 損傷（外因）（オレンジ線）* 不明（緑線）* 循環器（赤線）* 呼吸器（紫線）* 消化器（茶線）* 中毒・外因（ピンク線）* 筋骨格（灰色線）2. 全体的な傾向: * グラフは、約20年間の各ICDカテゴリの件数の変化を追跡しています。 * 全体的に見て、「症状・異常所見」が最も件数が多く、一貫して増加傾向にあります。 * 「不明」のカテゴリが、特定の期間に非常に劇的な変化を示しているのが特筆すべき点です。 3. 各カテゴリの件数推移の詳細: * 症状・異常所見（青線）: * この期間を通じて最も件数が多いカテゴリです。 * 2003年頃の約2000件から始まり、一貫して増加傾向にあり、特に2018年以降は急激に増加し、2024年には5500件を超えています。 * これは、診断が確定する前の症状や検査異常の段階での受診や記録が増加している可能性を示唆しています。 * 損傷（外因）（オレンジ線）: * 2003年頃の約2400件から始まり、2018年頃までは2000〜2500件の間で比較的安定して推移していました。 * 2018年以降は緩やかに増加し、2024年には3000件を超えています。 * 事故や外傷などによる受診件数が、近年やや増加していることを示しています。 * 不明（緑線）: * このカテゴリは最も劇的な変化を示しています。 * 2003年から2018年頃までは比較的低い水準（500〜1000件程度）で推移していました。 * しかし、2019年頃から急激に増加し始め、2022年には3500件を超えるピークに達しています。 * その後、2022年から2024年にかけては急激に減少しています。 * この急増と急減は、特定の期間において診断が困難なケースが増加したか、あるいはデータ入力や分類方法に一時的な変更があった可能性を示唆しています。 * 循環器（赤線）: * 2003年頃の約1300件から、2008年頃にかけて一時的に減少（約1000件）しましたが、その後は緩やかに増加傾向に転じ、2024年には約1400件となっています。 * 心臓病や高血圧などの循環器系の疾患による受診件数は、比較的安定しているか、わずかに増加していることを示します。 * 呼吸器（紫線）: * 2003年頃の約200件から、一貫して緩やかな増加傾向にあり、2024年には約1000件に達しています。 * 呼吸器系の疾患（例：喘息、肺炎、COPDなど）による受診件数が、着実に増加していることを示唆しています。 * 消化器（茶線）: * 2003年頃の約800件から、比較的安定して推移しており、大きな変動は見られません。2024年時点でも約800件です。 * 消化器系の疾患による受診件数は、この期間を通じてほぼ横ばいであることを示します。 * 中毒・外因（ピンク線）: * 2003年頃の約200件から、緩やかな増加傾向にあり、2024年には約600件に達しています。 * 中毒や特定の外因による健康問題の件数が、徐々に増加していることを示します。 * 筋骨格（灰色線）: * このカテゴリは最も件数が少なく、2003年頃の約300件から、期間を通じてほとんど変化がなく、2024年でも約500件とわずか

な増加に留まっています。 ＊
筋骨格系の疾患による受診件数は、この上位8カテゴリの中では最も少ない水準で安定していることを示します。 4. まとめ: このグラフは、日本の医療データ（または特定のデータセット）における疾病分類の傾向を時系列で示しており、特に「症状・異常所見」の増加と、「不明」カテゴリの特異な変動が注目されます。これらの変化は、医療現場での診断プロセスの変化、疾病構造の変化、あるいはデータ収集・分類方法の変更など、様々な要因を反映している可能性があります。

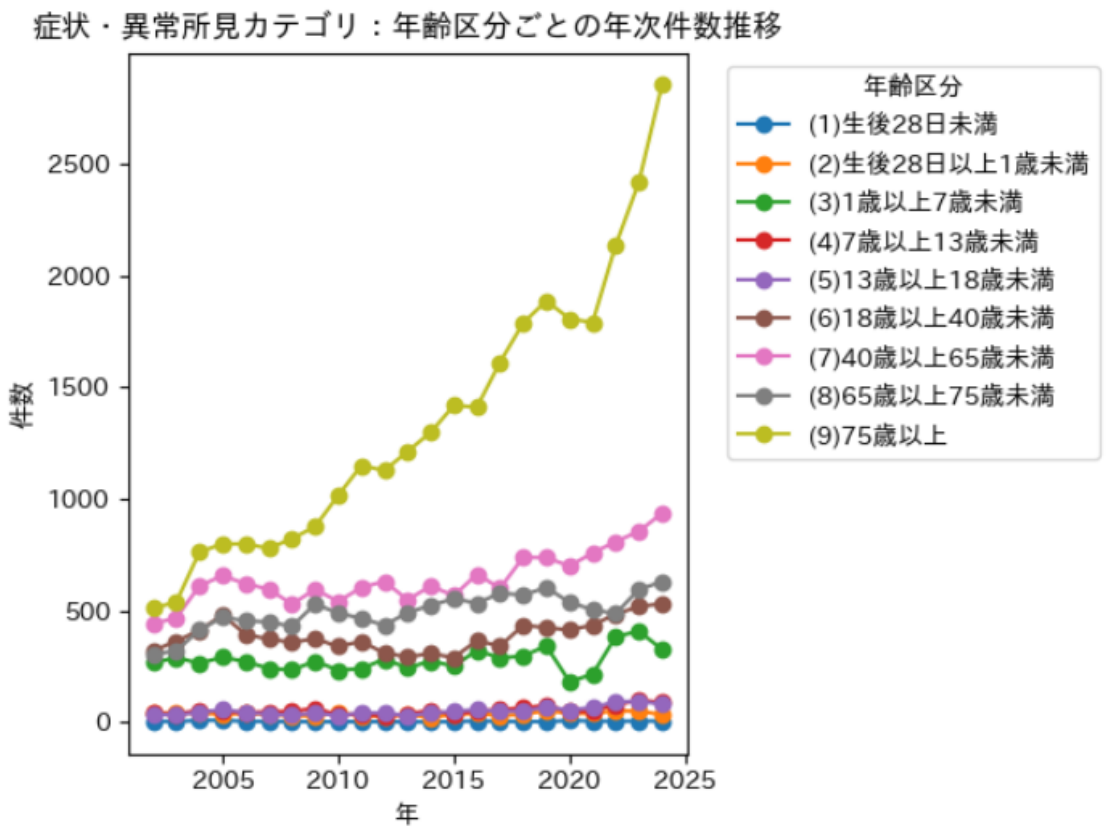

図6: 【図6】(Page 4): この画像（図6）は、「症状・異常所見カテゴリ」における、年齢区分ごとの年間件数の推移を示した折れ線グラフです。 詳細な説明は以下の通りです。 1. グラフの目的と全体像: ＊ このグラフは、特定の「症状」や「異常所見」として報告された事象の件数が、過去約20年間（2003年頃から2024年頃まで）でどのように変化してきたかを、年齢層別に示しています。 ＊
全体として、多くの年齢層で件数が増加傾向にありますが、特に高齢者層での増加が顕著です。 2. 軸の説明: ＊
横軸（年）: 2003年から2024年までの年次を表しています。 ＊ 縦軸（件数）:
報告された症状や異常所見の年間件数を表しており、0件から約2800件までの範囲で示されています。 3.
凡例（年齢区分）:
グラフには9つの異なる年齢区分が設定されており、それぞれ異なる色の線で件数の推移が描かれています。 ＊ (1) 生後28日未満（青色） ＊ (2) 生後28日以上1歳未満（オレンジ色） ＊ (3) 1歳以上7歳未満（緑色） ＊ (4) 7歳以上13歳未満（赤色） ＊ (5) 13歳以上18歳未満（紫色） ＊ (6) 18歳以上40歳未満（茶色） ＊ (7) 40歳以上65歳未満（ピンク色） ＊ (8) 65歳以上75歳未満（灰色） ＊ (9) 75歳以上（黄色） 4. 主な傾向と分析: ＊
「75歳以上」の急増（黄色い線）: ＊
最も顕著な傾向は、黄色い線で示される「(9)75歳以上」の年齢区分における件数の劇的な増加です。 ＊ 2003年頃には年間約500件だったものが、2024年には約2800件近くにまで増加しており、他のどの年齢層よりも大幅な伸びを見せています。これは、日本の高齢化の進展と、それに伴う高齢者の健康問題の増加を強く示唆しています。 ＊
中高年層の増加（ピンク色、灰色）: ＊ 次に件数が多いのは、ピンク色の線で示される「(7)40歳以上65歳未満」と、灰色の線で示される「(8)65歳以上75歳未満」の年齢区分です。 ＊ これらの層も全体的に増加傾向にありますが、「75歳以上」の層ほどの急激な増加ではありません。特に「40歳以上65歳未満」は2003年頃の約400件から2024年には約900件近くまで増加しています。 ＊
若年層・成人層の比較的安定した推移（青、オレンジ、緑、赤、紫、茶色）: ＊ 「(6)18歳以上40歳未満」（茶色）や「(3)1歳以上7歳未満」（緑色）の件数は、比較的安定しているか、緩やかな増減を繰り返しています。緑色の線は2020年頃に一時的に減少した後、再び増加に転じています。 ＊ 「(1)生後28日未満」（青色）、「(2)生後28日以上1歳未満」（オレンジ色）、「(4)7歳以上13歳未満」（赤色）、「(5)13歳以上18歳未満」（紫色）といった若年層

の件数は、全期間を通じて非常に少なく、ほぼ横ばいで推移しており、年間100件を超えることはほとんどありません。 5. 結論: このグラフは、特に高齢者層、中でも75歳以上の層において、症状や異常所見として報告される件数が年々著しく増加している傾向を示しています。これは、日本の高齢化社会における健康問題の増加、医療ニーズの増大、あるいは健康意識の高まりや医療アクセスの改善などが複合的に影響している可能性を反映していると考えられます。

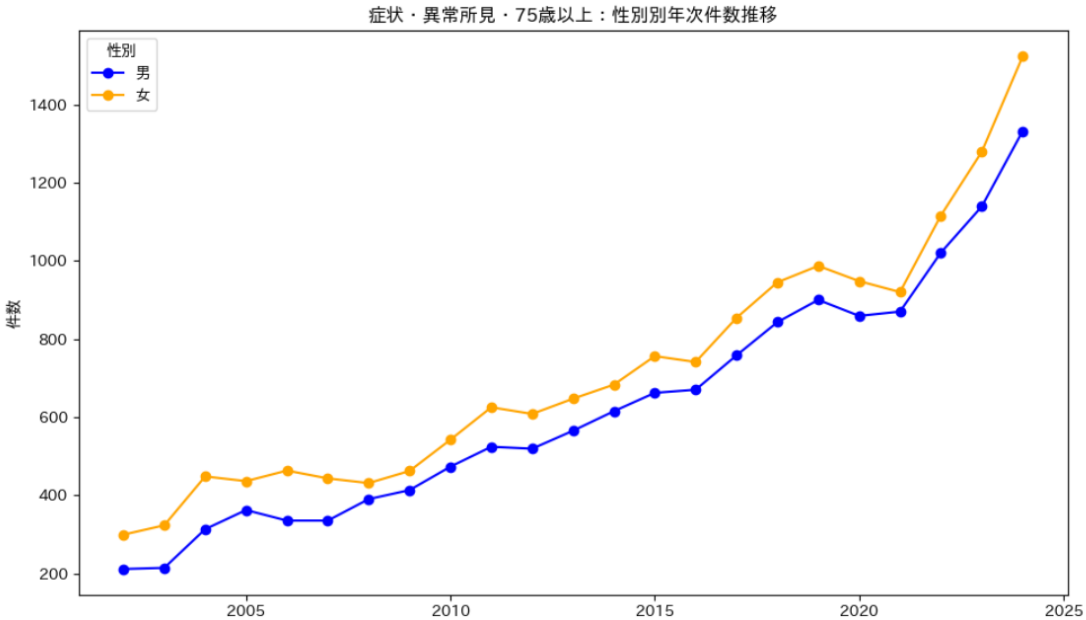

図7: 【図7】(Page 4): この画像（図7）は、75歳以上の高齢者における「症状・異常所見」の年間件数の推移を性別ごとに示したグラフです。 詳細に説明すると以下のようになります。 1. グラフのタイトル: ＊ 「症状・異常所見・75歳以上：性別年次件数推移」 ＊ これは、グラフが「症状」や「異常所見」に関するデータを扱っており、対象は「75歳以上の高齢者」であること、そして「性別」ごとの「年間件数」の「推移」（時間の経過による変化）を示していることを意味します。 2. 横軸（X軸）: ＊ 「年」を表しており、おおよそ2003年から2024年までの期間のデータが示されています。 3. 縦軸（Y軸）: ＊ 「件数」を表しており、報告された症状や異常所見の数を数値で示しています。200件から1400件以上まで目盛りが振られています。 4. 凡例（Legend）: ＊ 「性別」として、2本の折れ線グラフが示されています。 ＊ 青い線（●）: 「男」（男性）の件数を表しています。 ＊ オレンジ色の線（●）: 「女」（女性）の件数を表しています。 5. グラフから読み取れる主な傾向: ＊ 全体的な増加傾向: 2003年から2024年にかけて、男女ともに75歳以上の高齢者における「症状・異常所見」の報告件数は一貫して増加傾向にあります。 ＊ 2003年頃は男性が約200件、女性が約300件程度でしたが、2024年近くでは男性が1300件台、女性が1500件台にまで増加しています。 ＊ 性別による件数の差: ＊ グラフの全期間を通じて、女性の件数（オレンジ色）は男性の件数（青色）よりも多い状態が続いています。 ＊ この件数の差は、特に2015年以降、やや拡大しているように見えます。 ＊ 一時的な変動: ＊ 全体的な増加トレンドの中にも、2008年頃や2019年頃に一時的に件数が減少する時期が見られますが、その後再び増加に転じています。 ＊ 近年の急増: ＊ 特に2021年以降、男女ともに件数が急激に増加している点が顕著です。 まとめ: この図は、日本の高齢化社会において、75歳以上の高齢者が経験する健康上の「症状」や「異常所見」の報告件数が、過去20年以上にわたって男女ともに顕著に増加しており、特に女性の件数が男性を上回って推移している状況を視覚的に示しています。

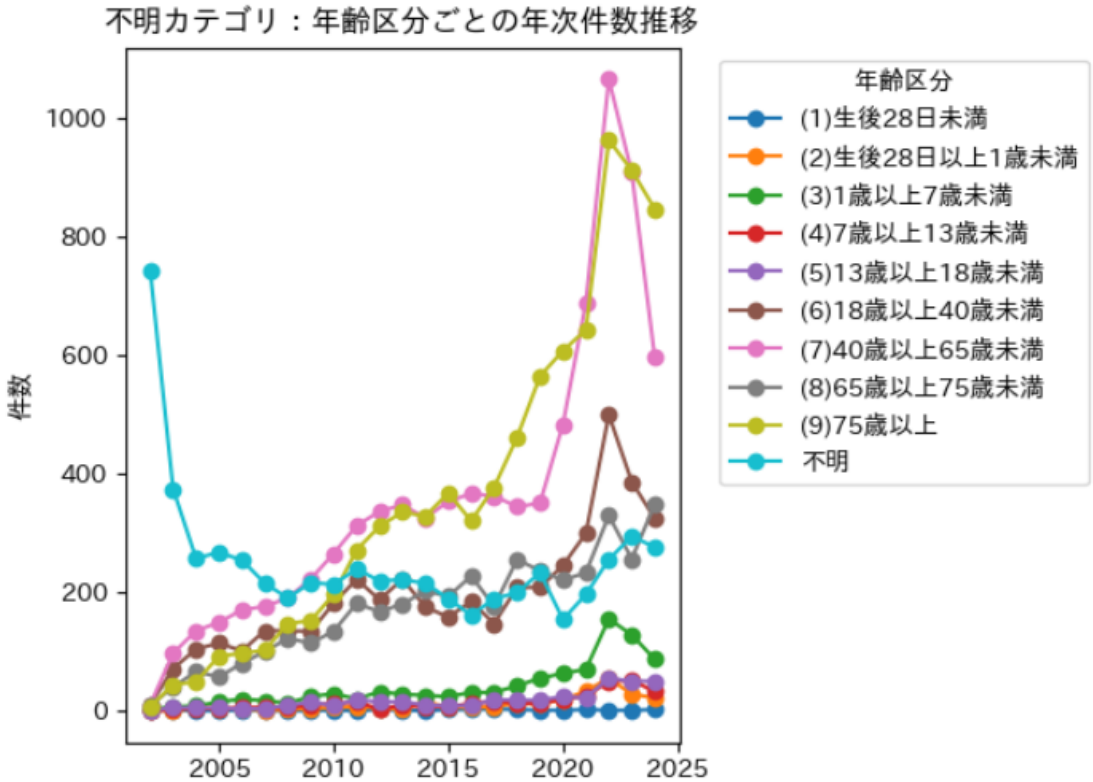

図8: 【図8】(Page 5): この画像（図8）は、「不明カテゴリ」に属する事象について、年齢区分ごとの年間件数の推移を示した折れ線グラフです。 以下に詳細を説明します。 1. グラフの全体的な目的と内容: * タイトル: 「不明カテゴリ：年齢区分ごとの年次件数推移」 * これは、何らかの「不明なカテゴリ」に分類される事象（例えば、原因不明の事故、疾患、報告など）の発生件数を追跡していることを示唆しています。 * その「不明カテゴリ」の事象が、時間の経過とともに、異なる年齢層でどのように変化しているかを示しています。 * X軸（横軸）: 年次（約2002年から2025年まで） * 時間の流れに沿った変化を追うことができます。 * Y軸（縦軸）: 件数 * 各年齢区分における年間発生件数を示しています。最大で1000件を超える件数が記録されています。 2. 凡例（年齢区分）の詳細: グラフは、以下の10の年齢区分に分けて件数を表示しています。 * (1) 生後28日未満（ネオネイタル期） * (2) 生後28日以上1歳未満（乳児期） * (3) 1歳以上7歳未満（幼児期・学童期初期） * (4) 7歳以上13歳未満（学童期） * (5) 13歳以上18歳未満（思春期・青年期初期） * (6) 18歳以上40歳未満（成人期初期） * (7) 40歳以上65歳未満（中年期） * (8) 65歳以上75歳未満（前期高齢者） * (9) 75歳以上（後期高齢者） * 不明（年齢が特定できないケース） 3. 主要なトレンドと観察事項: * 若年層（(1)～(5)）の件数: * 生後28日未満から18歳未満までの年齢区分は、全期間を通じて件数が非常に少なく、ほとんどの年で50件を下回っています。これらの年齢層では、「不明カテゴリ」の事象が稀であるか、あるいは別のカテゴリで報告されている可能性が考えられます。 * 成人期・中年期・高齢者層（(6)～(9)）の件数増加: * 2005年頃から、特に中年期以降の年齢層で件数が増加する傾向が見られます。 * 最も顕著な増加: * (7) 40歳以上65歳未満（ピンク色の線）: 2015年頃から急激に件数が増加し始め、2022年頃には1000件を超えるピークに達しています。これは全年齢区分の中で最も高い件数です。 * (9) 75歳以上（黄色の線）: 同様に2010年頃から着実に増加し、2022年頃には900件近くのピークに達しています。 * (8) 65歳以上75歳未満（灰色の線）: 2010年頃から増加傾向にあり、2022年頃に300～400件程度のピークを迎えています。 * (6) 18歳以上40歳未満（茶色の線）: 他の高齢者層ほどではないものの、2015年頃から増加し、2022年頃に500件程度のピークに達しています。 * これらの年齢層では、2022年頃に件数がピークに達した後、わずかに減少しているように見えます。 * 「不明」年齢区分（水色の線）の動向: * グラフの初期（2002年頃）には、年齢不明の件数が約750件と非常に高かったですが、その後2005年頃にかけて急激に減少し、200～300件台で推移しています。 * この初期の急減は、データ収集方法の改善や、年齢情報の記録がより徹底されるようになったことを示唆している可能性があります。その後は比較的安定していますが、2020年以降はやや増加傾向にあります。 4. 全体的な傾向のまとめ: このグラフは、「不明カテゴリ」に属する事象の年間発生件数が、特に中年期から高齢者層にかけて、2000年代半ばから顕著に増加していることを示しています。特に2022年頃に多くの年齢層でピークを迎え、その後わずかに減少する傾向が見られます。若年層では件数が一貫して低い一方で、データ収集初期には年齢不明のケースが多かったものの、その後改善された可能性が示唆されます。このデータは、特定の期間における「不明カテゴリ」の事象が、高齢化社会の進展や特

定の社会・環境要因と関連している可能性を示唆しているかもしれません。

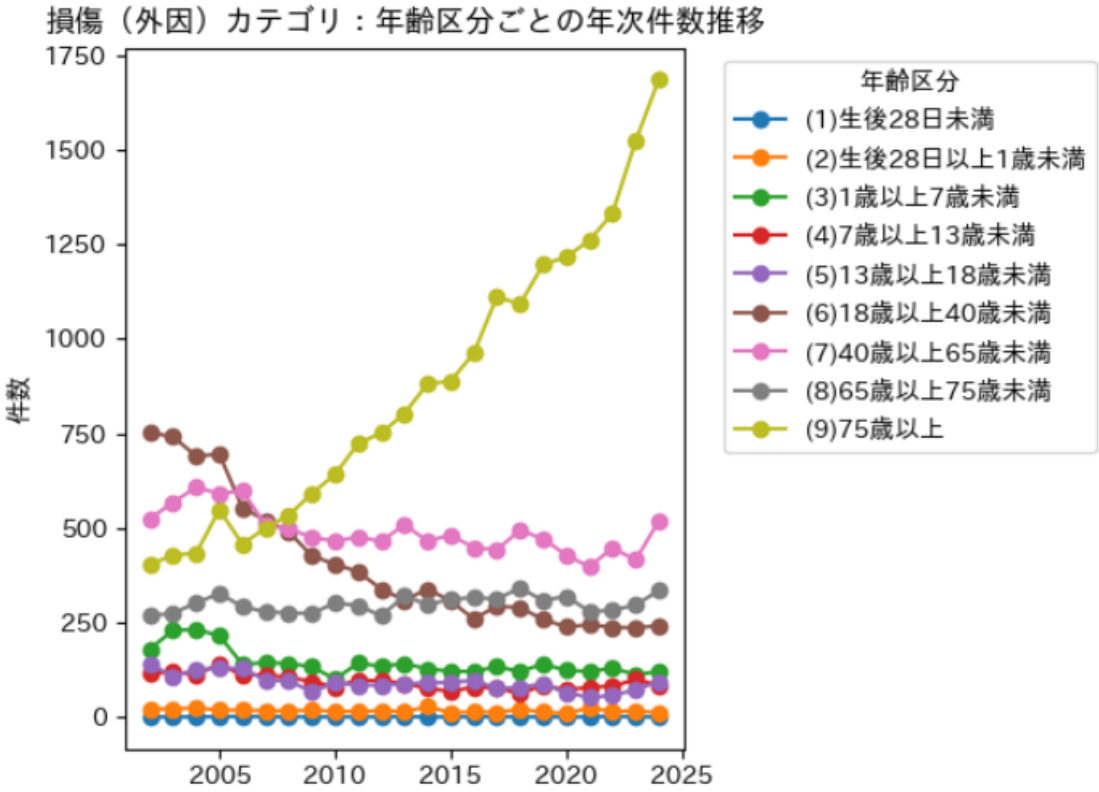

図9: 【図9】(Page 5): この画像（図9）は、「損傷（外因）」カテゴリにおける、年齢区分ごとの年間発生件数の推移を2003年頃から2024年頃までの期間で示した折れ線グラフです。 詳細な説明は以下の通りです。 1. グラフのタイトルと目的: ＊ タイトル: 「損傷（外因）カテゴリ: 年齢区分ごとの年次件数推移」 ＊ 目的: 外部要因による損傷（怪我など）の発生件数が、各年齢層でどのように年々変化しているかを示すことで、特定の年齢層におけるリスクの変化や社会的な傾向を把握することを目的としています。 2. 軸の説明: ＊ 横軸（X軸）: 年次（おおよそ2003年から2024年まで） ＊ 縦軸（Y軸）: 件数（0件から1750件まで） 3. 凡例（年齢区分）: グラフは以下の9つの年齢区分に分けられています。 ＊ (1) 生後28日未満 ＊ (2) 生後28日以上1歳未満 ＊ (3) 1歳以上7歳未満 ＊ (4) 7歳以上13歳未満 ＊ (5) 13歳以上18歳未満 ＊ (6) 18歳以上40歳未満 ＊ (7) 40歳以上65歳未満 ＊ (8) 65歳以上75歳未満 ＊ (9) 75歳以上 4. 各年齢区分の件数推移と主な傾向: ＊ 乳幼児・児童・青少年（(1)～(5)）: ＊ 生後28日未満（青）と生後28日以上1歳未満（オレンジ）: 期間を通じて件数は非常に少なく、ほぼ横ばいで推移しています（年間数十件程度）。 ＊ 1歳以上7歳未満（緑）、7歳以上13歳未満（赤）、13歳以上18歳未満（紫）: これらの年齢層も件数は比較的少なく、初期（2003年頃）は100～250件程度でしたが、その後は緩やかに減少または横ばいで推移し、近年では100件前後の水準で安定しています。 ＊ 成人（(6)～(7)）: ＊ 18歳以上40歳未満（茶色）: グラフの初期（2003年頃）には最も高い件数（約750件）を示していましたが、その後は一貫して大幅な減少傾向にあり、2024年頃には約250～300件まで減少しています。 ＊ 40歳以上65歳未満（ピンク）: 2003年頃は約500件で推移していましたが、その後は比較的安定しており、若干の増減を繰り返しながらも、近年では400～500件程度の水準を維持しています。 ＊ 高齢者（(8)～(9)）: ＊ 65歳以上75歳未満（灰色）: 期間を通じて比較的安定しており、250～300件程度の水準で推移しています。 ＊ 75歳以上（黄色）: この年齢層が最も顕著な変化を示しています。 2003年頃は約350～400件と他の年齢層と比較して中程度の件数でしたが、その後は一貫して急激な増加を続け、2024年頃には1700件を超える水準に達し、全年齢層の中で圧倒的に最も高い件数となっています。 5. 全体的な傾向と考察: ＊ このグラフから、外部要因による損傷の発生件数は、特に75歳以上の高齢者層で劇的に増加していることが明らかです。これは、日本の高齢化社会の進展と、高齢者の活動量の増加、あるいは転倒などの事故リスクの増加といった要因が複合的に影響している可能性を示唆しています。 ＊ 一方で、かつて最も件数が多かった18歳以上40歳未満の層では件数が大幅に減少しており、他の若年層や中年層では比較的安定または微減傾向にあります。 ＊ 全体として見ると、外部要因による損傷の件数は、若年層から中年層にかけては横ばいか減少傾向にあるものの、超高齢者層での急増が全体の件数を押し上げている構図が読み取れます。

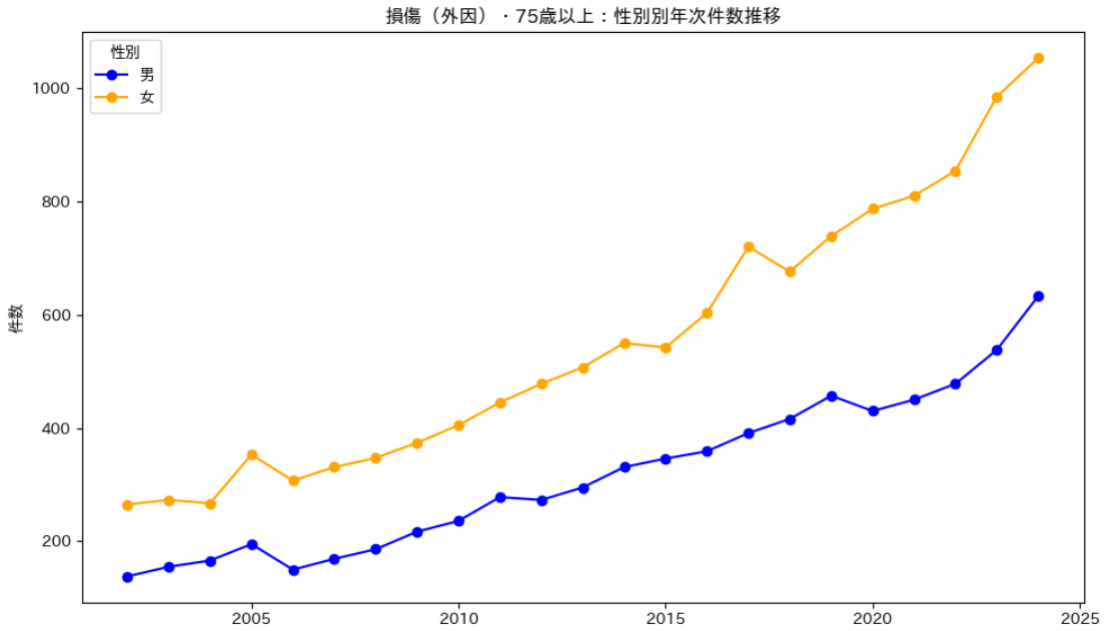

図10: 【図10】(Page 6): この画像（図10）は、「損傷（外因）・75歳以上：性別年次件数推移」というタイトルが示す通り、75歳以上の高齢者における外因による損傷の年間件数が、性別ごとにどのように推移しているかを示した折れ線グラフです。 以下に詳細を説明します。 1. グラフのタイトル: ＊ 「損傷（外因）」: 病気など内的な原因ではなく、転倒、事故、暴力など外部からの要因によって生じた怪我や損傷を指します。 ＊ 「75歳以上」: 分析対象となる年齢層が75歳以上の高齢者に限定されていることを示します。 ＊ 「性別年次件数推移」: 男女別に、年ごとの件数の変化（トレンド）を示していることを意味します。 2. 軸の説明: ＊ 横軸（X軸）: 年次を表しており、おおよそ2003年から2024年までの約20年間のデータが示されています。 ＊ 縦軸（Y軸）: 「件数」を表しており、0件から1000件を超える範囲で目盛りが振られています。 3. 凡例: ＊ 青色の線（●）: 男性（男）の件数を示します。 ＊ オレンジ色の線（●）: 女性（女）の件数を示します。 4. グラフから読み取れる主な傾向: ＊ 全体的な増加傾向: 2003年から2024年にかけて、男性・女性ともに75歳以上の外因による損傷件数は一貫して増加傾向にあります。これは、高齢化の進展や高齢者の活動性の変化など、複数の要因が背景にあると考えられます。 ＊ 女性の件数が一貫して多い: グラフ全体を通して、女性（オレンジ色の線）の件数は男性（青色の線）の件数を大幅に上回っています。 ＊ 2003年頃には女性が約250件程度であったのに対し、男性は約130件程度でした。 ＊ 2024年近くになると、女性は1000件を超え、男性は約600件程度に達しています。 ＊ 増加のペース: ＊ 女性: 2003年頃の約250件から始まり、比較的安定して増加を続け、特に2017年以降は増加のペースが加速し、2024年近くには1000件を突破しています。 ＊ 男性: 2003年頃の約130件から始まり、女性に比べて件数は少ないものの、同様に増加傾向にあります。特に2017年以降は増加の傾きが急になっています。 ＊ 男女間の件数差: 絶対数で見ると、男女間の件数差は年々拡大しているように見えます。例えば、2003年頃は約120件の差でしたが、2024年近くには約400件以上の差に広がっています。 まとめ: このグラフは、過去約20年間で、75歳以上の高齢者における外因による損傷の件数が男女ともに顕著に増加していることを示しています。特に女性の件数が男性を大きく上回り、その差も拡大傾向にあることが明らかです。このデータは、高齢者の安全対策や転倒予防など、公衆衛生上の重要な課題を示唆していると言えます。

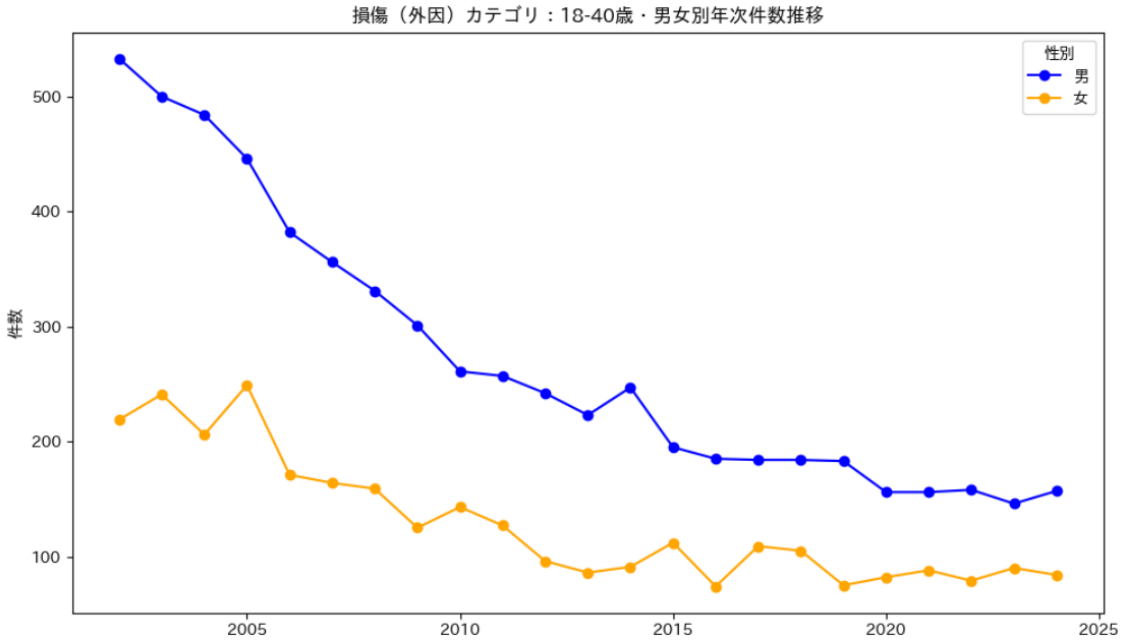

図11: 【図11】(Page 6): この画像（図11）は、18歳から40歳までの年齢層における、外因による損傷（怪我など）の年間件数の性別ごとの推移を、2003年頃から2024年頃まで示した折れ線グラフです。 詳細な説明は以下の通りです。 1. グラフのタイトルと目的: * タイトルは「損傷（外因）カテゴリ：18-40歳・男女別年次件数推移」です。 * これは、外部からの要因によって引き起こされた損傷（例えば、事故、暴力、自己傷害など）の件数を、18歳から40歳までの特定の年齢層に絞り、男性と女性で分けて、年ごとの変化を追跡したものです。 2. 軸の説明: * 横軸（X軸）: 年を表しており、2003年頃から2024年頃までの期間が示されています。 * 縦軸（Y軸）: 「件数」を表しており、損傷の発生件数を示しています。目盛りは100件刻みで、0件から500件以上まで表示されています。 3. 凡例（性別）: * 青い線（●）: 男性（男）の件数を示しています。 * オレンジ色の線（●）: 女性（女）の件数を示しています。 4. データの傾向: * 男性（青い線）の傾向: * 観測期間の初期（2003年頃）には、530件を超える非常に高い水準から始まっています。 * その後、2013年頃までにかけて急激な減少傾向を示し、約220件まで落ち込みます。 * 2015年頃には一時的に増加して250件程度になりますが、その後は再び減少傾向となり、2020年頃には150件台まで低下します。 * 2020年以降はやや回復し、2024年頃には160件程度で推移しています。 * 全体として、この期間を通じて大幅な減少が見られます。 * 女性（オレンジ色の線）の傾向: * 男性と比較して一貫して低い水準で推移しています。 * 2003年頃は約220件から始まり、2004年頃には240件程度まで増加しますが、その後は変動を繰り返しながら全体的に減少傾向にあります。 * 特に2013年頃には90件を下回る水準まで減少し、その後も100件前後で推移することが多く、2017年頃と2020年頃には70件台まで落ち込む時期も見られます。 * 直近の2024年頃では、80件台後半で推移しています。 * 男性ほど急激ではありませんが、長期的に見ると減少傾向にあります。 5. 男女間の比較: * この期間を通じて、男性の損傷件数は女性の件数を大幅に上回っています。特に初期の差は顕著で、男性は女性の2倍以上の件数がありました。 * 両性ともに長期的な減少傾向が見られますが、男性の減少幅は女性よりも顕著です。 * 件数の差は初期に比べて縮小しているものの、依然として男性の方が高い件数で推移しています。 まとめ: このグラフは、18歳から40歳の若年成人層において、外因による損傷の件数が過去約20年間で男女ともに減少傾向にあることを示しています。特に男性の件数は初期に非常に高かったものの、大幅に減少しました。しかし、期間を通じて男性の件数は女性の件数を一貫して上回っています。